Centraal Verbinden

FEITELIJK RAPPORTEREN

& PROFESSIONEEL COMMUNICEREN

Jeugdwet & Forensische Zorg (IFZO) Versie 3.1

Van uitleg naar professioneel werkinstrument

Praktijkvoorbeelden • Twijfelprotocol • Audit-proof werken • Ketencommunicatie

Deel 1 Waarom dit belangrijk is

Rapporteren is geen administratieve verplichting die je afvinkt aan het einde van een dienst. Het is een professionele verantwoordelijkheid met directe gevolgen voor de kwaliteit van zorg, de veiligheid van cliënten en de juridische positie van jouw organisatie.

Binnen de forensische zorg en jeugdhulp zijn rapportages niet alleen intern. Ze worden gelezen door reclassering, rechters, het Openbaar Ministerie, gemeenten en inspecties. Wat jij schrijft, bepaalt mede hoe anderen beslissen. Een ontbrekende observatie, een vaag geformuleerd signaal of een subjectief oordeel kan de verkeerde beslissing in gang zetten.

> Kernboodschap: Wat je niet feitelijk rapporteert, bestaat niet en kan tegen je werken. Een goede rapportage beschermt jou, jouw collega's én de cliënt.

Vijf redenen om feitelijk te rapporteren

Ten eerste verhoog je de kwaliteit van zorg. Nauwkeurige rapportages geven begeleiders en behandelaren de informatie die ze nodig hebben om goede beslissingen te nemen. Ten tweede maak je risico's zichtbaar: binnen RNR en FARE zijn jouw observaties de grondstof voor risicoanalyses. Ten derde bescherm je jezelf juridisch, toezichthouders en rechters beoordelen jouw werk op basis van wat er staat, niet op basis van wat je bedoelde. Ten vierde zorg je voor eenduidige communicatie met reclassering en gemeente. Ten vijfde voorkom je escalaties: veel conflicten in de keten beginnen bij een verkeerd geformuleerde rapportage.

Deel 2 Wat is feitelijk rapporteren?

Feitelijk rapporteren betekent: observeren, beschrijven en onderbouwen zonder interpretatie, mening of emotie. Ons brein is van nature geneigd om te interpreteren. We zien iemand die zijn armen over elkaar slaat en denken direct: hij is boos. Maar is dat zo? Feitelijk rapporteren vraagt dat je die eerste conclusie uitstelt en alleen beschrijft wat je daadwerkelijk hebt waargenomen.

Feit, interpretatie en mening het verschil

Type	Omschrijving	Voorbeeld
Feit	Waarneembaar, controleerbaar gedrag	Cliënt verliet de ruimte om 14:30 uur zonder iets te zeggen.
Interpretatie	Een verklaring die je aan een feit geeft	Cliënt leek boos te zijn en wilde niet samenwerken.
Mening	Een persoonlijk oordeel	Ik vind dat cliënt zijn best niet doet.

Interpretaties en meningen zijn niet verboden. Ze mogen in een rapportage verschijnen, maar alleen als ze expliciet als zodanig zijn gelabeld: ‘Observatie medewerker:’ of ‘Indruk begeleider:’. Wat niet mag, is een interpretatie presenteren als feit.

Correct gebruik van ‘Observatie medewerker’

Het label ‘Observatie medewerker:’ is een professioneel instrument, geen vrijbrief. Medewerkers die dit label te vaak gebruiken, ondermijnen de feitelijkheid van hun eigen rapportage. Gebruik het daarom alleen in de twee situaties hieronder, en nooit meer dan één keer per rapportage.

Gebruik ‘Observatie medewerker:’ uitsluitend wanneer:

- Er sprake is van een herkenbaar patroon over meerdere momenten of dagen.
- De interpretatie direct relevant is voor de risico-inschatting (RNR / FARE).

Gebruik dit label maximaal één keer per rapportage.

Onderbouw de observatie altijd met de feitelijke waarnemingen waarop ze is gebaseerd, het label staat nooit los.

Deel 3 Do’s en don’ts bij rapporteren

Het verschil tussen een sterke en een zwakke rapportage zit in kleine keuzes. Onderstaand overzicht maakt dat zichtbaar.

✅ WEL DOEN	❌ NIET DOEN
Beschrijf concreet en observeerbaar gedrag	Schrijf geen aannames (‘hij zal wel…’)
Noteer altijd datum, tijd en context	Stel geen diagnoses, tenzij bevoegd
Gebruik citaten van de cliënt indien relevant	Laat geen emoties of frustraties doorschemeren
Koppel aan doelen of justitiële voorwaarden	Gebruik geen vage termen (‘ging niet goed’)
Maak onderscheid tussen feit en interpretatie	Presenteer geen interpretaties als feiten
Schrijf professioneel en neutraal	Gebruik geen beschuldigende taal
Sluit aan bij risicofactoren (RNR/ FARE)	Schrijf niet dramatiserend of overdreven
Benoem afwijkingen van het zorgplan	Laat risico’s onvermeld bij twijfel

Basisvoorbeeld gedrag beschrijven

❌ FOUT	✅ GOED
Cliënt was agressief en werkte totaal niet mee. Hij deed gewoon niet wat er van hem verwacht werd.	Op 24-03-2026 om 14:30 uur weigerde cliënt deel te nemen aan het geplande gesprek. Cliënt verhief zijn stem, sloeg éénmaal met zijn vlakke hand op tafel en verliet de ruimte. Begeleider vroeg cliënt te blijven. Cliënt gaf aan: ‘Ik ga hier niet aan meewerken.’ Er was geen verdere escalatie. Leidinggevende is geïnformeerd.

Deel 4 Rapporteren in de praktijk, van eenvoudig tot complex

De volgende casussen komen uit de dagelijkse realiteit van forensische zorg en jeugdhulp. Ze zijn complexer dan de basisvoorbeelden en vragen om professionele afweging. Herken je de situatie? Dan weet je wat er van je wordt verwacht.

Situatie:

Casus 1 Mogelijk wapenbezit (IFZO)

❌ FOUT	✅ GOED
Ik had het idee dat cliënt met verkeerde dingen bezig was. Hij deed raar en ik vertrouwde het niet.	Op 12-03-2026 om 19:45 uur zag begeleider dat cliënt een voorwerp uit zijn tas haalde. Het voorwerp leek op een mes van ongeveer 20 centimeter. Begeleider sprak cliënt hierop aan. Cliënt stopte het voorwerp direct terug en verliet de ruimte. Situatie is dezelfde avond gemeld bij de leidinggevende. Reclasseringsmedewerker is om 20:15 uur telefonisch geïnformeerd. Observatie medewerker: het voorwerp was niet duidelijk zichtbaar als wapen, maar de vorm en afmeting gaven aanleiding tot melding.

Waarom dit cruciaal is: Bij mogelijk wapenbezit gelden meldplichten. Door feitelijk te beschrijven wat je zag en niet wat je dacht is jouw rapportage houdbaar in een juridische procedure.

Relatie RNR: Wapenbezit is een dynamische risicofactor. Documenteer altijd, ook bij twijfel.

Situatie:
Casus 2 Manipulatief gedrag (IFZO/ Jeugdwet)

❌ FOUT	✅ GOED
Cliënt is manipulatief. Hij liegt altijd en probeert iedereen om zijn vinger te winden.	Cliënt gaf op 14-03-2026 twee verschillende verklaringen over zijn verblijfplaats: Om 09:30 uur: 'Ik was bij mijn moeder.' Om 14:00 uur (zelfde dag): 'Ik was bij een vriend.' Bij doorvragen kon cliënt geen concrete details noemen (naam vriend, adres). Dit wijkt af van gemaakte afspraken over transparantie (zorgplan d.d. 01-02-2026, artikel 4.3). Observatie medewerker: de tegenstrijdige verklaringen geven aanleiding tot nadere afstemming.

'Manipulatief' is een diagnose en een oordeel. Rechters en reclassering kunnen er niets mee. Twee tegenstrijdige verklaringen met tijdstip en context zijn onweerlegbaar. Beschrijf het gedrag, de lezer trekt zijn eigen conclusie.

Situatie:
Casus 3 Emotionele trigger bij de begeleider

❌ FOUT	✅ GOED
Ik werd er echt boos van. Hij deed het expres om mij te raken. Dit was echt niet te doen.	Tijdens het gesprek op 15-03-2026 om 10:00 uur verhief cliënt herhaaldelijk zijn stem. Cliënt onderbrak de begeleider vijf à zesmaal binnen tien minuten. Begeleider heeft het gesprek om 10:20 uur tijdelijk beëindigd en een vervolgafspraak gepland voor 17-03-2026. Cliënt is gevraagd de ruimte te verlaten en deed dit zonder verdere incidenten. Leidinggevende is dezelfde dag mondeling geïnformeerd.

Eigen emoties horen niet in een rapportage. Ze vertekenen het beeld, zijn niet controleerbaar en verzwakken jouw professionele positie.

Wat wel mag: na afloop een intervisieaanvraag of melding doen over eigen belasting. Maar dat is een apart traject, niet de rapportage.

Situatie:

Casus 4 Vermoeden van middelengebruik (IFZO)

❌ FOUT	✅ GOED
Het was duidelijk dat cliënt gedronken had. Hij stonk naar drank en was agressief. Cliënt had zeker gebruikt.	Op 18-03-2026 om 21:30 uur keerde cliënt terug in de woonvoorziening. Er was een sterke alcohollucht waarneembaar in de directe omgeving van cliënt. Cliënt liep onvast ter been en reageerde vertraagd op vragen. Cliënt weigerde medewerking aan een blaastest. Volgens het zorgplan geldt een alcoholverbod voor cliënt. Leidinggevende is om 21:45 uur geïnformeerd. Reclassering is de volgende ochtend schriftelijk geïnformeerd. Observatie medewerker: directe bevestiging van gebruik was niet mogelijk, maar de waarnemingen geven sterk aanleiding tot verder onderzoek.

Deel 5 Wanneer moet je opschalen?

Rapporteren is niet altijd genoeg. In een aantal situaties ben je als professional verplicht om direct te handelen en op te schalen naar je leidinggevende en/of een ketenpartner. Wachten, twijfelen of intern overleggen zonder actie is in die gevallen professioneel tekortschieten.

🔴 **Professionele norm bij signalen:**

🔴 Meld altijd direct bij leidinggevende én ketenpartner bij:

- Vermoeden van wapenbezit
- Middelengebruik bij een verbod
- Overtreding van justitiële voorwaarden
- Veiligheidsrisico voor cliënt of omgeving

Direct betekent: nog dezelfde dienst, schriftelijk vastgelegd.

	Situatie	Wanneer en hoe handelen
🔴	**Vermoeden van wapenbezit**	Direct: leidinggevende + reclassering/ G.I. Nog dezelfde dienst, schriftelijk.
🔴	**Middelengebruik bij verbod**	Direct: leidinggevende. Reclassering uiterlijk volgende ochtend schriftelijk.
🔴	**Overtreding justitiële voorwaarden**	Zelfde dag schriftelijk melden aan reclassering.
🔴	**Veiligheidsrisico cliënt of omgeving**	Direct: leidinggevende + zo nodig hulpdiensten. Daarna schriftelijk vastleggen.
🟡	**Herhaald verzuim (≥2x in 2 weken)**	Binnen 24 uur overleg met leidinggevende en/of behandelcoördinator.
🟡	**Onbekende contacten bij netwerkverbod**	Zelfde dienst melden bij leidinggevende; vastleggen in dossier.
🟡	**Patroon van gedragsverandering**	Inbrengen in eerstvolgende teamoverleg; leidinggevende informeren.
🟢	**Eenmalige kleine afwijking zonder risico**	Rapporteren in dossier; geen directe actie vereist.

De kleuren zijn niet willekeurig: rood betekent direct handelen nog dezelfde dienst, geel binnen 24 uur, groen rapporteren zonder directe actie. Twijfel je over de kleur? Ga dan altijd één niveau hoger.

Deel 6 Wat doe je bij twijfel?

Dit hoofdstuk ontbreekt in veel readers en trainingen, maar het is voor de dagelijkse praktijk cruciaal. Want wat doe je als je iets vermoedt maar niet zeker weet? Wat als je een signaal opvangt maar het niet kunt bevestigen? Het antwoord is altijd hetzelfde: rapporteer wat je wél hebt waargenomen, en benoem je onzekerheid expliciet.

Basisregel bij twijfel:

Beschrijf altijd wat je hebt waargenomen, ook als het onvolledig is.

Benoem onzekerheid expliciet: ‘Observatie medewerker:’ of ‘Dit kon niet worden bevestigd.’

Rapporteer nooit je vermoedens als feiten.

Meld bij twijfel altijd bij je leidinggevende, de beslissing over relevantie ligt niet bij jou alleen.

Drieluik: vermoeden, signaal en bevestigd feit

Type	Omschrijving	Hoe rapporteer je
Bevestigd feit	Je hebt het zelf gezien of gehoord	Beschrijf direct wat je hebt waargenomen met datum/tijd.
Signaal	Iets wat opvalt maar niet bevestigd is	Beschrijf de waarneming + label: ‘Observatie medewerker:’
Vermoeden	Je denkt dat iets het geval is	Schrijf wat je wél hebt gezien, label je vermoeden apart.

Voorbeelden bij twijfel

Drugs niet direct bevestigd

❌ FOUT	✅ GOED
Het was duidelijk dat hij gebruikt had. Ik weet zeker dat hij high was.	Er is geen direct gebruik van middelen waargenomen. Wel werd om 20:00 uur een sterke geur waargenomen in de gang waar cliënt aanwezig was. Cliënt was zichtbaar onrustig, sprak snel en maakte geen oogcontact. Observatie medewerker: deze combinatie van signalen geeft aanleiding tot melding, maar gebruik is niet vastgesteld.

Netwerk onbekende contacten

❌ FOUT	✅ GOED
Cliënt had vast weer contact met zijn criminele netwerk. Die lui kennen we.	Op 20-03-2026 om 18:30 uur stond een voor begeleider onbekende man bij de ingang. Cliënt sprak ongeveer vijf minuten met deze persoon en ging daarna naar binnen. De man is niet geïdentificeerd. Er vond geen overdracht van voorwerpen plaats. Observatie medewerker: contact gemeld omdat onbekende bezoekers niet zijn toegestaan volgens de voorwaarden.

Gedragsverandering geen duidelijke oorzaak

❌ FOUT	✅ GOED
Cliënt doet raar de laatste tijd. Er klopt iets niet.	In de periode 15-03 tot 22-03-2026 is het volgende patroon waargenomen: Cliënt trok zich driemaal terug uit groepsactiviteiten zonder opgave van reden. Cliënt reageerde vertraagd op vragen en maakte weinig oogcontact. Dit wijkt af van eerder waargenomen gedrag en de basismetingen in het RNR-rapport (d.d. 20-02-2026). Observatie medewerker: patroon is ingebracht in het teamoverleg van 23-03-2026.

Deel 7 Rapportagestructuur: SBAR

SBAR is een internationaal erkende rapportagestructuur die wordt gebruikt in de zorg, het justitiële systeem en de veiligheidssector. Het staat voor Situatie, Background (achtergrond), Assessment (analyse) en Recommendation (actie). Beide varianten: Engels en Nederlands zijn gangbaar in audits en ketenoverleg.

Letter	NL/ EN	Vraag die je beantwoordt	Valkuil
S	**Situatie**	Wat is er nu aan de hand?	*Te vaag: 'het gaat niet goed'*
B	**Background/ Achtergrond**	Wat is de relevante voorgeschiedenis?	*Te veel: irrelevante details*
A	**Assessment/ Analyse**	Wat zie je feitelijk? Wijkt dit af?	*Interpretatie als feit presenteren*
R	**Recommandation/ Actie**	Wat is de volgende stap?	*Geen actie benoemen, alles openlaten*

SBAR uitgewerkt forensisch voorbeeld

Situatie: Op 22-03-2026 verscheen cliënt niet op de verplichte contactafspraak om 09:00 uur. Telefonisch contact om 09:15 en 09:45 uur leverde geen gehoor op.

Background (Achtergrond): Cliënt neemt volgens de bijzondere voorwaarden (d.d. 10-01-2026, artikel 3) iedere werkdag deel aan de verplichte contactafspraak. In de twee weken voorafgaand verzuimde cliënt al tweemaal zonder melding vooraf.

Assessment (Analyse): Het patroon van herhaaldelijk verzuim zonder contact is een overtreding van de gestelde voorwaarden en sluit aan bij de risicofactor 'sociaal terugtrekgedrag' (RNR-rapport d.d. 20-02-2026). Er zijn drie incidenten gedocumenteerd in vier weken.

Recommendation (Actie): Reclasseringsmedewerker is dezelfde dag schriftelijk geïnformeerd. Overleg met behandel coördinator gevraagd voor 24-03-2026. Cliënt wordt bij eerstvolgende contact aangesproken.

Deel 8 Communicatie met ketenpartners

Professionele communicatie in de keten gaat over herleidbaarheid, eenduidigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Wat je mondeling afspreekt maar niet schriftelijk vastlegt, bestaat niet. Wat je in een appgroep besluit, is juridisch niet afdwingbaar.

✅ WEL DOEN	❌ NIET DOEN
Blijf feitelijk, ook mondeling	'Ik heb het gevoel dat…', niet in professioneel overleg
Leg gemaakte afspraken direct schriftelijk vast	Inhoudelijke besluiten nemen in appgroepen
Gebruik gedeelde begrippen (RNR, zorgplan)	Schuld neerleggen bij de cliënt of ketenpartner
Benoem risico's concreet en onderbouwd	Aannames presenteren als vastgestelde feiten
Stuur bij gebrek aan respons een schriftelijke follow-up	Frustratie over de keten uiten in het dossier
Vraag door bij onduidelijkheid	Openlaten wie verantwoordelijk is voor een actie

Communicatie onder druk

De meest risicovolle communicatiemomenten zijn niet de rustige overleggen, maar de momenten van frustratie, tijdsdruk of conflict in de keten. Juist dan glijdt professionele taal snel af naar emotionele uitspraken die niets oplossen en alles vastleggen wat je achteraf niet meer wil lezen.

❌ FOUT	✅ GOED
We moeten hier echt iets mee, dit gaat zo niet goed. Als reclassering dit niet oppakt, doe ik het zelf wel.	In de afgelopen drie weken zijn vier geplande afspraken niet nagekomen (zie rapportages d.d. 03, 10, 17 en 24-03-2026). Dit wijkt structureel af van het vastgestelde plan. Er is tweemaal schriftelijk contact gezocht met reclassering zonder respons (zie e-mails d.d. 10 en 14-03-2026). Verzoek om formele besluitvorming over vervolgstappen vóór 28-03-2026.

Voorbeelden zoals het echt gaat

Geen respons van reclassering

❌ FOUT	✅ GOED
Reclassering doet ook niks, dus zo gaat het niet werken. Typisch.	Op 10-03-2026 en 14-03-2026 is telefonisch contact gezocht met de reclasseringsmedewerker. Op beide momenten werd niet opgenomen; er is een voicemail ingesproken. Op 14-03-2026 is ook een e-mail verzonden. Tot op 18-03-2026 is geen reactie ontvangen. Het verzoek om afstemming over de situatie van cliënt blijft staan.

Melding aan gemeente (Jeugdwet)

❌ FOUT	✅ GOED
Ik denk dat de situatie thuis niet goed is. De ouders doen ook niet mee.	Op 17-03-2026 is een huisbezoek afgelegd. Moeder opende de deur niet, ondanks een voorafgaande afspraak. Telefonisch contact op dezelfde dag bleef onbeantwoord (twee pogingen: 10:15 en 13:30 uur). Dit is de tweede keer in twee weken dat een geplande afspraak niet doorging. Dit wijkt af van het gezinsplan d.d. 10-02-2026. De gezinscoach is dezelfde dag geïnformeerd. Afstemming over vervolgstappen is gevraagd.

Afspraken vastleggen na overleg

❌ FOUT	✅ GOED
We hebben gebeld en afgesproken dat we het even aankijken. Iedereen was het ermee eens.	Telefonisch overleg op 19-03-2026 (aanwezig: begeleider, reclasseringsmedewerker, behandel coördinator). Besluit: cliënt wordt de komende twee weken dagelijks gecontroleerd op aanwezigheid. Bij herhaaldelijk verzuim wordt een terugmelding ingediend. Actiepunten: begeleider rapporteert dagelijks; reclassering evalueert op 02-04-2026. E-mailbevestiging verzonden op 19-03-2026 aan alle betrokkenen.

Wanneer is een rapportage onbruikbaar?

Een onbruikbare rapportage is erger dan geen rapportage. Ze geeft een vertekend beeld, ondermijnt de besluitvorming van ketenpartners en maakt jouw organisatie kwetsbaar bij audits en juridische procedures. Herken de kenmerken, zodat je ze kunt voorkomen.

Onbruikbaarheidsfactor	Waarom dit een probleem is
Geen datum of tijdstip	Zonder tijdsmarkering is de rapportage niet reconstrueerbaar en juridisch niet bruikbaar.
Gedrag niet concreet beschreven	'Moeilijk', 'lastig' of 'niet goed' zijn niet controleerbaar. Wat deed de cliënt precies?
Interpretaties als feiten gepresenteerd	'Cliënt is manipulatief' is een diagnose. 'Cliënt gaf twee tegenstrijdige verklaringen' is een feit.
Geen koppeling met doelen of voorwaarden	Een rapportage zonder relatie met het zorgplan of de justitiële voorwaarden is stuurloos.
Geen opvolging vastgelegd	Wat is er na de observatie gedaan? Wie is geïnformeerd? Wat is het resultaat?
Emoties of oordelen van de medewerker zichtbaar	'Ik werd er echt boos van' of 'hij doet het expres' horen niet in een professioneel dossier.

Een rapportage die aan één of meer van bovenstaande punten voldoet, dient te worden herschreven voordat deze wordt gebruikt als onderbouwing voor een beslissing, melding of rapportage aan een ketenpartner.

Twijfel je of jouw rapportage bruikbaar is? Gebruik de checklist achter in deze reader.

Deel 9 Audit-proof rapporteren (KFZ/ ISO/ HKZ)

Toezichthouders zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Keurmerk Forensische Zorg (KFZ) en gemeenten beoordelen jouw rapportages niet op intentie, maar op kwaliteit. Een goed bedoelde rapportage die niet aan de eisen voldoet, is in een audit evenveel waard als een slechte.

Vier criteria waarop jouw rapportage wordt beoordeeld

Criterium	Wat het betekent	Hoe je dit bereikt
Controleerbaarheid	Een externe partij kan nagaan of de informatie klopt.	Datum, tijd, namen en documenten opnemen. Citaten letterlijk weergeven.
Herleidbaarheid	Duidelijk is wie wat heeft gedaan, wanneer en waarom.	Noteer altijd wie rapporteert, wie aanwezig was en welke stappen zijn gezet.
Objectiviteit	De rapportage is vrij van mening of emotie.	Gebruik feitentaal. Label interpretaties expliciet als zodanig.
Consistentie	Dezelfde situatie wordt door alle medewerkers gelijk beschreven.	Gebruik vaste structuren (SBAR) en gedeelde begrippen.

Vijf vragen die een auditor stelt

1. Zijn afwijkingen van het zorgplan of de voorwaarden gedocumenteerd?
2. Is duidelijk wie welke actie heeft ondernomen en wanneer?
3. Zijn risicosignalen benoemd en doorgezet naar de juiste partij?
4. Zijn er citaten of directe observaties, of alleen samenvattingen?
5. Wordt er consistent gerapporteerd door het hele team?

Veelvoorkomende audit-bevindingen

❌ FOUT	✅ GOED
Geen datum of tijdstip bij observaties. Actiepunten beschreven maar niet opgevolgd of afgerond. Risicosignalen vermeld, maar geen melding of actie gedocumenteerd. Verschillende medewerkers beschrijven dezelfde situatie tegenstrijdig.	Iedere observatie bevat datum, tijd en naam van de rapporterende medewerker. Actiepunten worden afgesloten met datum en resultaat. Bij ieder risicosignaal staat: wat is gedaan, wie is geïnformeerd, wanneer. Het team hanteert een vaste structuur (SBAR) en gedeeld begrippenkader.

Deel 10 Oefeningen

De volgende oefeningen zijn bedoeld om het geleerde direct toe te passen. Gebruik ze individueel of in teamverband. Er zijn geen standaardantwoorden: het gaat om het gesprek dat de oefening oplevert.

Oefening 1 Herschrijf de rapportage

Herschrijf onderstaande rapportage zo dat ze feitelijk, professioneel en audit-proof is.

FOUT: ‘Cliënt was vandaag weer lastig. Hij luisterde nergens naar en deed echt zijn best niet.
Ik heb geprobeerd een gesprek te voeren maar hij werkte gewoon niet mee.
Hij deed het expres. Er is niks goed gegaan vandaag. Typisch voor hem.’

Jouw herschreven versie:

Oefening 2 Feit, interpretatie of mening?

Beoordeel per uitspraak het type (F = feit, I = interpretatie, M = mening). Bespreek daarna hoe je de interpretaties en meningen herschrijft als feiten.

1. Cliënt verliet de ruimte zonder iets te zeggen. *F / I / M*
2. Cliënt is boos op de begeleider. *F / I / M*
3. Cliënt reageerde niet op drie opeenvolgende vragen. *F / I / M*
4. Cliënt heeft moeite met gezag. *F / I / M*
5. Cliënt haalde een voorwerp uit zijn tas dat leek op een mes. *F / I / M*
6. Cliënt was duidelijk onder invloed. *F / I / M*
7. Cliënt gaf twee tegenstrijdige verklaringen over zijn verblijfplaats. *F / I / M*
8. Cliënt is manipulatief. *F / I / M*

Oefening 3 SBAR opstellen (forensisch dilemma)

Lees de casus en schrijf een volledige SBAR. Let op: er is sprake van twijfel, pas de twijfelregels toe.

Casus: Je begeleidt Rashid (28, IFZO) met een alcoholverbod als bijzondere voorwaarde.

Jouw collega vertelt dat Rashid gisteren laat terugkwam, rook naar drank en een onbekende man meenam die een uur later vertrok.

Jijzelf was er niet bij. Je spreekt Rashid vanmorgen: hij ontkent alles en zegt dat jouw collega 'liegt'.

Jouw collega heeft niets vastgelegd.

Situatie:

Achtergrond:

Analyse:

Actie:

Deel 10 Checklists voor dagelijks gebruik

Gebruik deze checklists als standaard eindcontrole na iedere rapportage en na ieder ketenoverleg.

Checklist — Feitelijke rapportage
☐ **Heb** ik uitsluitend beschreven wat ik heb waargenomen?
☐ **Is** er een datum, tijdstip en context aanwezig?
☐ **Heb** ik interpretaties en meningen vermeden, of duidelijk gelabeld?
☐ **Is** de rapportage gekoppeld aan doelen, het zorgplan of justitiële voorwaarden?
☐ **Zijn** afwijkingen van het plan expliciet benoemd?
☐ **Heb** ik risicosignalen gedocumenteerd en doorgezet?
☐ **Zijn** citaten van de cliënt letterlijk weergegeven?
☐ **Is** de taal neutraal en professioneel (geen emoties, geen oordelen)?
☐ **Kan** een externe partij de situatie reconstrueren op basis van deze rapportage?
☐ **Is** duidelijk wie wat heeft gedaan, wanneer en wat het resultaat was?

Checklist — Communicatie met ketenpartners
☐ **Is** alle informatie die ik deel feitelijk onderbouwd?
☐ **Heb** ik mijn aannames gecheckt voor ik communiceerde?
☐ **Zijn** gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in het dossier?
☐ **Heb** ik de juiste kanalen gebruikt (geen gevoelige informatie via app)?
☐ **Is** duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke actie?
☐ **Heb** ik bij uitblijvende respons een schriftelijke follow-up gestuurd?

Checklist — Twijfelsituaties
☐ **Heb** ik beschreven wat ik wél heb waargenomen, ook als het onvolledig is?
☐ **Heb** ik mijn onzekerheid expliciet benoemd met een label?
☐ **Heb** ik mijn vermoeden niet gepresenteerd als vastgesteld feit?
☐ **Heb** ik de situatie gemeld bij mijn leidinggevende?
☐ **Is** gedocumenteerd dat er twijfel was en hoe daarmee is omgegaan?

© Centraal Verbinden — Alle rechten voorbehouden

Dit document is bestemd voor intern gebruik en training binnen de organisatie.
Verveelvoudiging of extern gebruik alleen na schriftelijke toestemming van Centraal Verbinden.